BỘ Y TẾ - CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH
VIỆN SỨC KHỎE TÂM THẦN LÂM SÀNG QUỐC GIA

Mã tài liệu: NC-LS-CBT-2021
Phân loại: Y văn kiểm định nội bộ

ĐÃ KIỂM TRA LƯU TRỮ
BẢN SCAN GỐC SỐ HÓA - 2021

BÁO CÁO THỰC THI LÂM SÀNG: SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA LIỆU PHÁP NHẬN THỨC HÀNH VI (CBT) VÀ PHÁC ĐỒ PHỐI HỢP SSRI TRÊN BỆNH NHÂN TRẦM CẢM NẶNG

TS. BS. Trần Minh Hoàng, ThS. Nguyễn Mai Phương — Phân viện Nghiên cứu Tâm lý Y sinh

1. TỔNG QUAN VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ

Rối loạn trầm cảm chủ yếu (Major Depressive Disorder - MDD) là một trong những gánh nặng y tế hàng đầu toàn cầu. Thực hành y học dựa trên bằng chứng (Evidence-Based Practice - EBP) đòi hỏi việc liên tục đánh giá đối sánh giữa các can thiệp tâm lý lâm sàng độc lập và phác đồ dược lý. Nghiên cứu này nhằm mục đích lượng hóa sự thay đổi điểm số trên các thang đo chuẩn tắc gồm BDI-II, PHQ-9 và mức độ lo âu đi kèm (GAD-7) sau liệu trình can thiệp kéo dài 12 tuần.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Cỡ mẫu nghiên cứu: N = 120 bệnh nhân (độ tuổi 22 - 58) được chẩn đoán xác định theo DSM-5.
- Thiết kế thử nghiệm: Nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng (Randomized Controlled Trial - RCT) được phân ngẫu nhiên thành 3 nhánh can thiệp độc lập (40 bệnh nhân / nhóm):
  - Nhóm A (CBT): 12 buổi trị liệu Nhận thức Hành vi theo mô thức của Aaron T. Beck.
  - Nhóm B (SSRI): Sử dụng Sertraline liều chuẩn 50mg - 100mg/ngày kết hợp tái khám định kỳ.
  - Nhóm C (Phối hợp): Trị liệu CBT song song với phác đồ Sertraline liều thấp 50mg/ngày.
- Tiêu chí đánh giá chính: Tỷ lệ giảm điểm BDI-II (Beck Depression Inventory) và PHQ-9 tại tuần thứ 12.

3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

Sau 12 tuần theo dõi liên tục, kết quả đánh giá lâm sàng trên 120 bệnh nhân được tổng hợp dưới đây:

Nhóm Can Thiệp	Cỡ Mẫu	BDI-II (Trước)	BDI-II (Sau 12w)	PHQ-9 (Sau 12w)	Tỷ lệ Giảm
Nhóm A: CBT đơn thuần	N = 40	32.4 ± 4.2	14.8 ± 3.1	6.2 ± 1.8	54.3% ($p < 0.01$)
Nhóm B: Dược lý SSRI	N = 40	33.1 ± 4.5	16.5 ± 3.6	7.4 ± 2.1	50.1% ($p < 0.01$)
Nhóm C: Phối hợp CBT+SSRI	N = 40	32.8 ± 4.3	10.2 ± 2.4	4.1 ± 1.2	68.9% ($p < 0.001$)

Bảng 2: Tỷ lệ thuyên giảm lâm sàng và Chỉ số an toàn

Chỉ số Lâm Sàng	Nhóm A (CBT)	Nhóm B (SSRI)	Nhóm C (Phối Hợp)	Ý Nghĩa Thống Kê
Tỷ lệ thuyên giảm (Remission)	62.5% (25/40)	55.0% (22/40)	82.5% (33/40)	Chi-square = 7.82, $p < 0.05$
Cỡ hiệu ứng (Cohen's d)	d = 0.74 (Khá)	d = 0.68 (Trung bình)	d = 0.95 (Rất mạnh)	Kiểm định đối chứng F-test
Tác dụng phụ ngoài ý muốn	0.0% (0/40)	22.5% (9/40)	10.0% (4/40)	Ghi nhận rối loạn tiêu hóa nhẹ
Tỷ lệ bỏ dở trị liệu (Dropout)	5.0% (2/40)	12.5% (5/40)	5.0% (2/40)	$p = 0.28$ (Không khác biệt)

Phát hiện cốt lõi: Nhóm phối hợp CBT và SSRI đạt mức độ suy giảm triệu chứng trầm cảm vượt trội (68.9%) so với hai nhóm đơn trị liệu. Đặc biệt, can thiệp CBT giúp duy trì hiệu quả tâm lý bền vững và hạn chế tối đa nguy cơ tái phát sau khi ngừng thuốc.

4. BÀN LUẬN VÀ KẾT LUẬN LÂM SÀNG

Kết quả thực nghiệm khẳng định liệu pháp Nhận thức Hành vi (CBT) đóng vai trò then chốt trong việc tái cấu trúc nhận thức sai lệch (Cognitive Distortions) và nâng cao khả năng điều hòa cảm xúc của người bệnh. Trong khi dược lý SSRI mang lại hiệu quả cải thiện sinh học nhanh trong 4 tuần đầu, CBT cung cấp các kỹ năng thích ứng nhận thức lâu dài giúp ngăn chặn trầm cảm kháng trị.

Khuyến nghị phác đồ:

1. Đối với trầm cảm mức độ trung bình: Ưu tiên chỉ định CBT đơn thuần 12-16 tuần.
2. Đối với trầm cảm mức độ nặng (BDI-II >= 29): Khuyến nghị phác đồ kết hợp ngay từ đầu giữa CBT và Sertraline liều thấp nhằm tối đa hóa tỷ lệ thuyên giảm (82.5%) và giảm thiểu tác dụng phụ.
3. Cần tích hợp các công cụ hỗ trợ hỏi đáp y văn như Acamind để bác sĩ tra cứu nhanh số liệu thực chứng.

5. XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU

BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ CHÍNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. BS. TRẦN MINH HOÀNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
(Ký và đóng dấu xác nhận)

PGS. TS. NGUYỄN VĂN HỌC